1. Observer : l'essentiel

But : décrire des faits utiles avant de les interpréter.

Regarder	Voir	Observer
Orienter le regard.	Percevoir visuellement.	Examiner pour repérer, comprendre et surveiller.

PAR CŒUR Observation **spontanée** = au fil des soins ; **dirigée** = centrée sur un objectif, avec critères.

Quoi observer ?

PERSONNE	ENVIRONNEMENT	DOSSIER
État physique, psychique, autonomie, douleurs.	Global • technique • architectural • social.	Antécédents, traitements, consignes, transmissions.

4 qualités : disponible • attentif • compétent • respectueux et discret.

ASTUCE « **Que vois-je, qu'entends-je, que dit la personne ?** » puis seulement : « Que puis-je en déduire ? »

2. Entretien + examen physique

MÉTHODE	CE QU'ELLE APPORTE
Observation	Indices que je perçois avec mes sens.
Entretien clinique	Données subjectives : « J'ai mal », histoire de santé, traitements, vécu.
Examen physique	Données objectives : signes observés et mesures pertinentes.

Les 4 techniques d'examen

INSPECTION	PALPATION	AUSCULTATION	PERCUSSION
Observer le corps et ses signes.	Explorer par le toucher.	Écouter les sons internes.	Produire des sons par tapotements.

LES 4 SENS CLINIQUES **Vue :** posture, peau. **Ouïe :** toux, sifflements, alarmes. **Odorat :** odeur inhabituelle. **Toucher :** chaleur, humidité.

VIGILANCE Expliquer et obtenir l'accord. Les examens / mesures doivent rester adaptés au contexte et aux compétences. Une odeur seule ne fait pas un diagnostic.

3. Biais, sécurité et transmissions

BIAIS	PIÈGE	BON RÉFLEXE
Confirmation	Je ne cherche que ce qui confirme mon idée.	Chercher aussi les faits contraires.
Ancrage	Je reste fixé sur la première info.	Réévaluer avec les nouvelles données.
Négativité	Je ne retiens que le mauvais.	Décrire aussi ressources / capacités.

FAITS ≠ JUGEMENTS « Dit : “J’ai peur”, pleure et demande une présence » est traçable ; « est pénible » ne constitue pas une observation clinique.

Rôle IDE / ESI en stage

- Surveiller les changements, croiser observation + entretien + examen + dossier.
- Sécuriser la chambre, protéger l’intimité, alerter en cas d’aggravation.
- Tracer l’heure, les faits, les mesures, les actions et la réponse du patient.

SAED - transmission orale **S**ituation • **A**ntécédents • **É**valuation • **D**emande (outil HAS).

4. Test minute • corrigé

Q1. « Je me sens très faible. » Subjectif ou objectif ? **Q2.** Une alarme de scope : quel sens ?

Q3. Nommer les 4 techniques d'examen physique. **Q4.** À quel biais correspond « je m'accroche à la première information » ?

Q5. Un patient tousse et respire plus vite qu'hier : donner 2 actions prioritaires.

CORRIGÉ **1.** Subjectif. **2.** Ouïe. **3.** Inspection, palpation, auscultation, percussion. **4.** Ancrage. **5.** Évaluer/vérifier la respiration et alerter selon la gravité ; sécuriser, transmettre, surveiller.

Mini-lexique

SUBJECTIF	OBJECTIF	BIAIS
Ressenti ou propos du patient.	Fait constaté ou mesuré.	Raccourci de pensée qui fausse le jugement.

FIL CONDUCTEUR **Je recueille → je recoupe → j'analyse → j'alerte / j'agis → je trace et j'évalue.**

Références : cours IFSI (28 p.) • Arrêté du 20/02/2026, UE A.1 • CSP R.4311-3 (en vigueur depuis 30/06/2026) • HAS, SAED (2014).